

CAPÍTULO 13.52

Cáncer de Cabeza y Cuello

PERFIL EUNACOM 1.03.1.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción y Factores de Riesgo

El cáncer de cabeza y cuello engloba una serie de tumores malignos que se originan en la mucosa de la **vía aerodigestiva superior** (fosas nasales, senos paranasales, cavidad oral, faringe y laringe).

El factor de riesgo más importante y determinante para el desarrollo de estas neoplasias es la **exposición al humo del cigarrillo**. El tabaquismo crónico genera una injuria constante sobre el epitelio respiratorio y digestivo superior.

- **Tabaco:** Causa principal por amplio margen.
- **Exposición laboral:** Contacto con químicos e irritantes industriales.
- **Alcohol:** Actúa de forma sinérgica con el tabaco, aumentando exponencialmente el riesgo.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología del cáncer de cabeza y cuello suele seguir la teoría de la **"cancerización de campo"**, donde toda la mucosa expuesta al carcinógeno (humo) tiene un riesgo aumentado de desarrollar lesiones premalignas y malignas en distintos puntos de forma simultánea o sincrónica.

Histología: Un Cáncer con Muchos Nombres

Es fundamental reconocer la terminología histológica, ya que en el examen EUNACOM se pueden utilizar distintos sinónimos para referirse a la misma entidad. El tipo histológico más frecuente (más del 90% de los casos) es el **cáncer de células escamosas**.

TABLA 13.52.1: TÉRMINO VS RELEVANCIA	
TÉRMINO	RELEVANCIA
Epidermoide	El término más utilizado en clínica.
Espinocelular	Referencia a la capa de células espinosas del epitelio.
Escamoso	Referencia a la morfología de las células.
Pavimentoso	Término clásico que describe la disposición en capas (como pavimento).

Enfrentamiento Clínico y Diagnóstico

La presentación clínica es altamente variable y depende estrictamente de la localización del tumor primario:

- **Nariz/Senos paranasales:** Obstrucción nasal unilateral, epistaxis, síntomas orbitales.
- **Cavidad oral:** Úlceras que no cicatrizan, dolor local, masas visibles.
- **Laringe:** El síntoma cardinal es la **disfonía** persistente (especialmente en cáncer glótico).
- **Faringe:** Disfagia, odinofagia o sensación de cuerpo extraño.

Algoritmo de Diagnóstico

- **Examen Físico Completo:** Es el primer paso obligatorio. Se debe realizar una inspección minuciosa de la boca, orofaringe y una palpación cervical sistemática en busca de adenopatías.
- **Endoscopia Dirigida:**
 - **Nasofibrolaringoscopia:** Permite visualizar fosas nasales, rinofaringe, hipofaringe y laringe.
 - **Endoscopia Digestiva Alta (EDA):** Para descartar compromiso esofágico o segundos primarios.
- **Imagenología:**
 - **TC (TAC) de cuello:** Es el estándar inicial. Permite ver la extensión local, invasión ósea y la presencia de adenopatías sospechosas.
 - **Resonancia Magnética (RM):** Superior para evaluar la invasión de partes blandas y compromiso perineural.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante un paciente adulto, fumador, con una **adenopatía cervical dura y adherida a planos profundos**, la primera sospecha debe ser siempre una metástasis de un cáncer de la vía aerodigestiva superior.

El Rol de la Biopsia

El diagnóstico definitivo **siempre es histológico**.

- Si el tumor primario es visible (ej. en la lengua o amígdala), se debe biopsiar directamente la lesión.
- **Manejo de la adenopatía cervical:** Si solo se palpa una masa en el cuello y no se encuentra el primario en el examen físico inicial, se prefiere realizar una **Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF o PAF)**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca se debe realizar una biopsia incisional (abierta) de una adenopatía cervical sospechosa de cáncer epidermoide sin haber agotado la búsqueda del primario. Hacerlo puede romper la cápsula ganglionar y diseminar el tumor, empeorando el pronóstico.

Etapificación y Tratamiento General

- Una vez confirmado el diagnóstico, se debe etapificar para definir la conducta terapéutica. Esto incluye:
- **TC de Cuello:** Evaluación de ganglios regionales.
- **TC de Tórax:** Búsqueda de metástasis a distancia (el pulmón es el sitio más frecuente) y descarte de segundos primarios pulmonares (común en fumadores).

Estrategias de Tratamiento

El pilar del tratamiento con intención curativa es la **cirugía**.

- **Resección del tumor primario:** Con márgenes oncológicos.
- **Disección cervical:** Extirpación quirúrgica de los niveles ganglionares del cuello, incluso si no son palpables (disección electiva) en ciertos casos.
- **Tratamiento Adyuvante:** Radioterapia (RT) o Quimioterapia (QT) postoperatoria según los hallazgos de la biopsia final (márgenes comprometidos, invasión extracapsular, etc.).

Excepciones al manejo general:

- **Tumores muy pequeños:** Pueden requerir solo cirugía o solo radioterapia, sin necesidad de disección cervical agresiva o quimioterapia.
- **Tumores avanzados/irreseccables:** Se utiliza **neoadyuvancia** (quimio/radio previa) para intentar reducir el tamaño tumoral antes de la cirugía.
- **Cáncer Glótico inicial:** Al estar en las cuerdas vocales, se puede optar por radioterapia exclusiva o microcirugía láser para preservar la función fonatoria.

Diagnóstico Diferencial: Linfoma y Cáncer de Tiroides

No todas las masas cervicales son cáncer epidermoide. Es vital diferenciar estas dos entidades:

1. Linfoma

Se sospecha cuando hay adenopatías múltiples, de consistencia "gomosa", acompañadas de **síntomas B** (fiebre, baja de peso, sudoración nocturna). - **Estudio:** Hemograma, VHS, LDH, TC de tórax/abdomen/pelvis. - **Biopsia:** A diferencia del cáncer epidermoide, aquí se requiere una **biopsia escisional** (sacar el

ganglio completo) para que el patólogo analice la arquitectura del tejido.

2. Cáncer de Tiroides

Se presenta generalmente como un nódulo tiroideo o una masa en la línea media/lateral baja del cuello. - **Estudio inicial:** TSH y Ecografía de cuello. - **Conducta según TSH:** - Si TSH está baja (hipertiroidismo): Solicitar Cintigrafía tiroidea. - Si TSH está normal o alta: Proceder a PAAF según criterios ecográficos.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda el orden del estudio del nódulo tiroideo: **1° TSH + Ecografía → 2° PAAF (si corresponde).**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 58 años, fumador de 40 paquetes-año, consulta por una masa cervical izquierda indolora de 3 semanas de evolución. Al examen físico se palpa una adenopatía dura, adherida a planos profundos. No se identifica lesión primaria en la inspección de la cavidad oral ni orofaringe. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Cáncer de Cabeza y Cuello. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Factor de riesgo principal: tabaquismo. Histología más frecuente: carcinoma epidermoide (= espinocelular = escamoso = pavimentoso).
- Enfrentamiento diagnóstico: 1) Examen físico completo → 2) Endoscopías (nasofibro, EDA) → 3) Imágenes (TAC/RMN).
- TAC: mejor para partes duras (hueso) e invasión ósea. RMN: mejor para partes blandas. TAC es más rápida y barata pero irradia.
- Diagnóstico definitivo: SIEMPRE biopsia. Se biopsia en el momento en que se identifica el tumor.
- Adenopatía cervical sin primario identificado → PAAF (punción aspiración con aguja fina) para no diseminar el tumor.
- Sospecha de linfoma (síntomas B) → biopsia EXCISIONAL (ganglio completo), NO PAAF.
- Etapificación: TAC de cuello + TAC de tórax (metástasis más frecuentes: pulmones).
- Tratamiento general: cirugía primario + disección cervical + radio/quimioterapia adyuvante.
- Excepciones: cáncer pequeño (solo cirugía), muy grande (neoadyuvancia primero), glótico localizado (radio/microcirugía para preservar voz).
- Cáncer de tiroides: TSH → ecografía → PAAF. Si hipertiroidismo → cintigrafía tiroidea antes de biopsiar.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO)

PREGUNTA 1

Hombre de 58 años, fumador de 40 paquetes-año, consulta por una masa cervical izquierda indolora de 3 semanas de evolución. Al examen físico se palpa una adenopatía dura, adherida a planos profundos. No se identifica lesión primaria en la inspección de la cavidad oral ni orofaringe. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Biopsia excisional de la adenopatía cervical
- B) Buscar el primario con nasofibro-laringoscopia y si no se encuentra, realizar PAAF de la adenopatía
- C) TAC de cuello y tórax como primer paso
- D) Antibióticos por 2 semanas y reevaluar
- E) Ecografía cervical con Doppler como estudio inicial

PREGUNTA 2

Paciente de 25 años con adenopatías cervicales bilaterales, fiebre de 2 semanas, baja de peso de 5 kg en un mes y sudoración nocturna. No se encuentra lesión primaria en cavidad oral ni faringe. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada para la adenopatía?

- A) Punción aspiración con aguja fina (PAAF)
- B) Biopsia excisional de adenopatía completa
- C) TAC de cuello y tórax antes de cualquier biopsia
- D) Hemograma y LDH, si normales se descarta linfoma
- E) Nasofibro-laringoscopia para buscar primario oculto

PREGUNTA 3

Respecto al manejo general del cáncer de cabeza y cuello de tipo epidermoide, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) La quimioterapia es el tratamiento con intención curativa
- B) En cánceres muy grandes, se debe operar de inmediato sin neoadyuvancia
- C) La cirugía incluye resección del primario más disección cervical, seguida de radio/quimioterapia adyuvante
- D) Las metástasis más frecuentes son hepáticas, por lo que se solicita ecografía abdominal
- E) La RMN es siempre superior al TAC y debe solicitarse como primer examen de imagen

RESUMEN: CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

El cáncer de cabeza y cuello de la vía aerodigestiva superior tiene como factor de riesgo principal la exposición al humo de cigarrillo, seguido por exposición a otros químicos irritantes laborales. La histología más frecuente es el carcinoma epidermoide (sinónimos: espinocelular, escamoso, pavimentoso). La clínica varía según la localización del tumor. El enfrentamiento diagnóstico sigue un orden sistemático: primero examen físico completo (buscar primario en boca, nariz, adenopatías cervicales); luego endoscopías (nasofibro-laringoscopia para fosas nasales, rinofaringe, hipofaringe y laringe; endoscopia digestiva alta para esófago); y finalmente imágenes (TAC para invasión ósea y adenopatías; RMN para invasión de partes blandas). El diagnóstico definitivo siempre es con biopsia. Si solo se encuentran adenopatías cervicales sin primario identificado, se realiza punción aspiración con aguja fina (PAAF) para evitar diseminación tumoral. Si la sospecha es linfoma, se hace biopsia excisional (ganglio completo). La etapificación se hace con TAC de cuello (adenopatías) y TAC de tórax (metástasis pulmonares, las más frecuentes). El tratamiento general es cirugía del primario + disección cervical (gangliolar) + radioterapia/quimioterapia adyuvante. Excepciones importantes: cáncer muy pequeño (solo cirugía sin radio/quimio); cáncer muy grande (neoadyuvancia con radio/quimio para reducirlo primero); cáncer glótico localizado (radioterapia o microcirugía para preservar la voz); linfoma (biopsia excisional, manejo hematológico); cáncer de tiroides (TSH + ecografía + PAAF, manejo específico).